Введение

Каждый день в России происходят тысячи чрезвычайных ситуаций: дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи в быту и на производстве, внезапные остановки сердца и дыхания. Во многих из них рядом с пострадавшим оказываются не врачи, а обычные люди — прохожие, соседи, коллеги, одноклассники. Именно от их знаний и решительности в первые минуты нередко зависит жизнь человека.

В медицине существует понятие «золотого часа»: если пострадавшему в течение этого времени оказана правильная помощь, шансы на выживание и полное выздоровление резко возрастают. При остановке сердца счёт идёт на минуты: без кислорода клетки головного мозга начинают необратимо погибать уже через четыре-пять минут, а бригада скорой помощи часто не успевает прибыть так быстро. Поэтому первая помощь, оказанная посторонним человеком, становится первым и самым важным звеном цепи выживания.

Актуальность темы обусловлена тем, что владение приёмами первой помощи необходимо каждому человеку независимо от профессии и возраста. Однако, по данным опросов, значительная часть населения не знает современных алгоритмов и придерживается устаревших и даже опасных приёмов, встречающихся в фильмах и литературе.

Цель — изучить основные принципы, правила и типовые алгоритмы оказания первой помощи.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: рассмотреть понятие и правовые основы первой помощи; изучить общий порядок действий при происшествии; разобрать алгоритм сердечно-лёгочной реанимации и правила помощи при кровотечениях, ожогах, отравлениях, травмах и других распространённых состояниях; выявить типичные ошибки, которых следует избегать.

1. Понятие и правовые основы первой помощи

Первая помощь — это комплекс срочных простейших мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья человека, проводимых на месте происшествия до прибытия медицинских работников или доставки пострадавшего в медицинскую организацию. От оказания первой помощи следует отличать первую медицинскую (доврачебную) помощь, которую выполняют специально обученные люди, имеющие необходимое оснащение.

В Российской Федерации первая помощь закреплена законодательно. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет её как особый вид помощи, а порядок её оказания утверждается приказом Министерства здравоохранения. Закон содержит и перечень мероприятий первой помощи: вызов скорой помощи, определение наличия сознания и дыхания, восстановление проходимости дыхательных путей, сердечно-лёгочная реанимация, остановка наружного кровотечения, обезболивание при переломах, согревание пострадавшего и другие действия.

Важна и правовая сторона вопроса. По закону оказывать первую помощь обязаны определённые категории граждан: водители при дорожно-транспортном происшествии, сотрудники полиции и других силовых структур, спасатели, медицинские работники, а также лица, чьи должностные обязанности это предусматривают. Остальные граждане вправе оказывать первую помощь добровольно. При этом закон «Охраняет» тех, кто помогает: лицо, действующее в состоянии крайней необходимости для спасения жизни и здоровья человека, не несёт ответственности за возможный причинённый вред, если действовало по правилам оказания первой помощи. Трудовое законодательство обязывает работодателей организовывать обучение своих сотрудников приёмам первой помощи.

Оснащение первой помощи определено приказом Министерства промышленности и торговли: в перечень входят средства для сердечно-

лёгочной реанимации (устройство для проведения искусственного дыхания), для остановки кровотечений (жгут, бинты, салфетки), иммобилизации, а также маска одноразовая, перчатки и ножницы. Перечень определяется для категорий лиц, обязанных оказывать первую помощь, и в целом лежит в основе современных аптечек первой помощи.

2. Общий алгоритм действий при оказании первой помощи

Правильная последовательность действий на месте происшествия — основа всей первой помощи. Она строится по принципу: сначала безопасность, затем оценка состояния, потом помощь. Основные этапы таковы:

Первый этап — оценка обстановки и обеспечение собственной безопасности. Оказывающий помощь должен убедиться, что ему самому ничто не угрожает: не соприкасается с токоведущими частями, не находится под обрушивающимися конструкциями, не стоит на дороге в потоке машин. При контакте с кровью и другими выделениями следует использовать перчатки или подручные средства. Спасать пострадавшего ценой своей жизни — грубая ошибка: вместо одного пострадавшего их станет два.

Второй этап — устранение действия поражающего фактора. Пострадавшего выводят из горящего или загазованного помещения, отодвигают от проезжей части, прерывают контакт с электрическим током. При этом перемещать пострадавшего нужно только если без этого нельзя: например, при подозрении на травму позвоночника переноска без необходимости утяжеляет травму.

Третий этап — оценка состояния пострадавшего. Проверяют признаки сознания (оклик, лёгкое потряхивание за плечи), затем наличие нормального дыхания: смотрят на движения грудной клетки, слушают и ощущают дыхание не более десяти секунд. Важно помнить об агональном дыхании — редких, судорожных, хриплых вдохах, которые характерны для терминального состояния и не считаются нормальным дыханием. Если дыхание отсутствует или агональное, пострадавший считается находящимся

в состоянии клинической смерти, и необходимо начинать реанимационные мероприятия.

Четвёртый этап — вызов скорой медицинской помощи. На территории России вызвать скорую можно по номеру 103, а по единому номеру экстренных служб — 112 (в том числе с мобильного телефона без SIM-карты и без денег на счёте). Диспетчеру следует чётко сообщить: адрес и заметный ориентир, что произошло, количество пострадавших, их состояние, а также назвать своё имя и оставаться на линии, пока не разрешат повесить трубку.

Пятый этап — оказание первой помощи с учётом приоритетов. В первую очередь устраняют непосредственные угрозы жизни: массивное кровотечение, отсутствие дыхания, нарушение проходимости дыхательных путей. Шестой этап — наблюдение за пострадавшим до прибытия медиков: его нельзя оставлять одного, нужно следить за сознанием и дыханием, укрыть от холода, успокоить.

3. Сердечно-лёгочная реанимация

Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление кровообращения и дыхания при их внезапном прекращении. Она проводится, если у пострадавшего отсутствуют сознание и нормальное дыхание. Современный алгоритм строится по правилу «С-А-В»: сначала компрессии грудной клетки, затем обеспечение проходимости дыхательных путей и только потом искусственное дыхание.

Последовательность действий следующая. Убедившись в отсутствии сознания и дыхания, нужно громко позвать на помощь и попросить окружающих вызвать скорую и принести автоматический дефибриллятор, если он есть поблизости. Затем начинают непрямой массаж сердца: руки располагают по центру грудной клетки (на нижнюю треть грудины), делают 30 компрессий на глубину пять-шесть сантиметров с частотой 100–120 в минуту. После этого выполняют два вдоха искусственного дыхания — «изо рта в рот» или с помощью специального устройства, при этом голову

пострадавшего запрокидывают, подбородок поднимают. Циклы «30 компрессий — 2 вдоха» повторяют непрерывно.

Если рядом обнаружен автоматический наружный дефибриллятор (АВД), его следует использовать как можно раньше: прибор сам анализирует сердечный ритм и при необходимости выдаёт разряд, сопровождая действия голосовыми подсказками, поэтому пользоваться им может и неподготовленный человек.

Реанимацию продолжают до прибытия бригады скорой помощи, появления у пострадавшего явных признаков жизни (сознания, нормального дыхания, движения) либо до полного истощения сил спасателя. Даже если проводить только компрессии без вдохов («hands-only» реанимация), шансы пострадавшего на выживание значительно возрастают — это особенно важно, когда спасатель один или боится делать вдохи.

4. Первая помощь при кровотечениях

Кровотечение — одна из самых частых и при этом наиболее устранимых угроз жизни. Его вид определяет способ помощи.

Капиллярное кровотечение (кровь выступает мелкими каплями из ссадины) останавливают промыванием раны чистой водой, обработкой краёв антисептиком и наложением давящей повязки. Антисептик не следует заливать внутрь раны — обрабатывают только края. Небольшое венозное кровотечение (тёмная кровь, вытекающая равномерно) обычно останавливается давящей повязкой.

Артериальное кровотечение — алая пульсирующая струя — требует немедленных действий. Сначала артерию прижимают пальцами выше раны или в типичных точках прижатия, затем накладывают кровоостанавливающий жгут на 5–7 сантиметров выше раны, предварительно защитив кожу тканью. К жгуту обязательно прикрепляют записку с точным временем наложения: летом конечность можно перетягивать не более двух часов, зимой — не более часа, после чего жгут необходимо ослабить или наложить заново чуть выше, иначе ткани начнут

отмирать. Если жгута нет, допускается наложение из подручных средств с закруткой либо тугое тампонирование раны бинтом или салфеткой.

Носовое кровотечение встречается часто. Правильно: слегка наклонить голову вперёд, прижать крыло носа к перегородке на 10–15 минут, приложить холод к переносице. Запрокидывать голову назад нельзя: кровь попадает в глотку и дыхательные пути, а видимое «остановленное» кровотечение создаёт ложное впечатление помощи.

При подозрении на внутреннее кровотечение (нарастающая слабость, бледность, холодный пот, боль в животе после травмы или сильного удара) наружных признаков может не быть, но состояние быстро ухудшается. В этом случае пострадавшему не дают пить и есть, укладывают, на живот прикладывают холод и немедленно вызывают скорую помощь.

5. Первая помощь при распространённых состояниях

Первая помощь при ожогах. Обожжённое место охлаждают прохладной проточной водой в течение 15–20 минут, затем аккуратно снимают украшения и одежду, не прилипшую к коже, и накрывают рану чистой сухой повязкой. Категорически нельзя смазывать ожог маслом, кремом, сметаной: плёнка удерживает тепло и ухудшает состояние, а прокалывать пузыри запрещено — это открывает путь инфекции.

Первая помощь при отравлениях. При вдыхании ядовитых газов и паров пострадавшего выводят на свежий воздух, расстёгивают стесняющую одежду. При попадании яда внутрь и сохранённом сознании нужно прополоскать рот водой; искусственно вызывать рвоту не следует при отравлении кислотами, щелочами, нефтепродуктами, а также у пострадавшего без сознания — возможен ожог пищевода повторным прохождением едкого вещества или попадание рвотных масс в дыхательные пути. Необходимо сохранить упаковку или остатки вещества и сообщить о них врачам.

Первая помощь при переломах и травмах. Конечность иммобилизуют в том положении, в котором она находится, не пытаясь вправлять: шина

должна фиксировать два соседних с переломом сустава. При подозрении на травму позвоночника (травма с падением с высоты, ДТП, онемение конечностей) пострадавшего не перемещают без крайней необходимости и не пытаются усадить. При потере сознания пострадавшего в сознании укладывают с приподнятыми ногами, расстёгивают одежду, обеспечивают приток воздуха; если сознание не вернулось за одну-две минуты, проверяют дыхание и при необходимости начинают СЛР.

Первая помощь при обморожении и переохлаждении. Пострадавшего переносят в тёплое помещение, снимают мокрую одежду, постепенно согревают, дают тёплое питьё. Нельзя растирать поражённые участки снегом или резко согревать у огня: это усиливает повреждение тканей. Обмороженные участки накрывают сухой повязкой.

Первая помощь при нарушении проходимости дыхательных путей. Если пострадавший в сознании и поперхнулся (судорожные попытки вдоха, синева губ, невозможность говорить и кашлять), выполняют приём Геймлиха: пять резких толчков в область живота выше пупка, направленных снизу вверх. Маленьких детей толчками в живот не выстукивают: используют удары основанием ладони между лопаток и толчки двумя пальцами в грудь. Если пострадавший потерял сознание — переходят к сердечно-лёгочной реанимации.

6. Типичные ошибки при оказании первой помощи

Практика показывает: пострадавшему вредит не только бездействие, но и неверные, часто «киношные» действия. К наиболее типичным ошибкам относятся:

— попытки перетаскивать пострадавшего с подозрением на травму позвоночника без крайней необходимости;

— наложение жгута без записки о времени наложения, что приводит к омертвению конечности;

— дача воды или еды пострадавшему с травмой живота, отравлению или без сознания;

— попытки «привести в чувство» при обмороке похлопыванием по щекам и тормошением;

— удерживание головы и вставление предметов между зубами во время судорог — вместо этого голову не удерживают, а обеспечивают безопасность, убрав опасные предметы;

— удаление инородного тела из глубокой раны — его следует фиксировать и не трогать до прибытия медиков, так как оно может удерживать повреждённый сосуд;

— смазывание ожога маслом и прокалывание пузырей;

— запрокидывание головы при носовом кровотечении.

Избежать этих ошибок позволяют регулярное повторение алгоритмов и практические занятия: знания, не закреплённые на манекенах и тренировках, в стрессовой ситуации часто забываются.

Заключение

Проведённое изучение темы позволяет сделать следующие выводы. Первая помощь — это не медицинская процедура, а общедоступный комплекс простейших действий, который может выполнить каждый человек на месте происшествия до прибытия врачей. Российское законодательство закрепляет перечень таких мероприятий и защищает тех, кто оказывает помощь добросовестно и по правилам.

Главная идея оказания первой помощи — последовательность: сначала обеспечить собственную безопасность, затем оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь (103 или 112) и действовать по чётким алгоритмам — сердечно-лёгочная реанимация, остановка кровотечения, охлаждение ожога, иммобилизация перелома. Приоритет всегда отдаётся угрозам, непосредственно опасным для жизни.

Не менее важно знать, чего делать нельзя: устаревшие приёмы, распространённые в быту и в кино, часто приносят вред вместо пользы. Регулярное прохождение курсов первой помощи и практические тренировки превращают знания в уверенные действия, а значит — в спасённые жизни.

Владение навыками первой помощи — признак зрелого и ответственного гражданина, и овладеть ими может каждый школьник.